منقو، قيرا

يقتل الحر هنا في الغالب عن طريق الأطفال المرضى أصلًا، ولذلك فإن أقوى إجراء لمواجهة الحر هو استمرار علاج سوء التغذية، وتوفير المياه في متناول الناس قبل شهر مارس.

الولاية	الوفيات الزائدة بسبب الحر	الفترة	الخطر الغالب
قيرا (على مستوى الولاية)	**980 وفاة متوقعة، منها 330 في أكتوبر و210 في مارس؛ و350 وقعت بالفعل (يونيو–سبتمبر)**	**توقعات لستة أشهر، أكتوبر 2026 – مارس 2027**	**الحر على الأطفال المرضى والمصابين بسوء التغذية؛ وشح المياه؛ والتهاب السحايا من يناير إلى مايو؛ وموسم الفجوة الغذائية لعام 2027**

تم التحقق من 15 توصية من أصل 15. صُحّحت 9 منها، و0 لم يُتحقَّق منها، و6 محظورة (البطاقات الست في قسم «لا تفعلوا هذا»؛ وإحداها، المتعلقة بالتطعيم القديم ضد التهاب السحايا، جاءت من مرحلة التحقق). كما تم التحقق من خطوات قسم «لكم» الثماني كلها، وصُحّحت 4 منها. رقم التعرّض: بيانات متتبّع وفيات الحر المرتبطة بظاهرة النينيو الصادر عن مختبر الأثر المناخي (Climate Impact Lab)، نسخة 26 أكتوبر 2026، قبل مراجعة الأقران، والمنهجية لم تُنشر بعد. وهو منشور لولاية قيرا لا لمدينة منقو، ويحصي الحر وحده. ولم تُحسب حصة منقو، لأنه تعذّر التأكد من عدد سكان المدينة الحالي. تقع قيرا خارج كل قنوات التمويل المرتّبة مسبقًا التي جرى فحصها: إطار الأمم المتحدة للعمل الاستباقي لمواجهة الجفاف، ومشروع شبكات الأمان التابع للبنك الدولي، وبروتوكول العمل المبكر للصليب الأحمر، والمناطق ذات الأولوية في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026. انخفض هدف التمويل من 249 مليون فرنك أفريقي (424,000 دولار أمريكي) الذي اقترحته اللجنة إلى 238 مليون فرنك أفريقي (405,800 دولار أمريكي) بعد التحقق (−4%). وأصبح بندان منه احتياطيين لا يُصرفان إلا عند تحقق شرط محدد.

الملخص التنفيذي **نظرة سريعة**



12.18° شمالًا 18.68° شرقًا، تشاد · Natural Earth

- **الخطر.** في قيرا، كان 13.3% من الأطفال الصغار يعانون من سوء التغذية الحاد في عام 2024، والأسر تدفع بالفعل 1,000–1,250 فرنكًا أفريقيًا يوميًا ثمنًا للمياه.
- **لكم.** في هذا الشهر، اعرضوا كل طفل دون الخامسة على المركز الصحي لقياس ذراعه بالشريط؛ والعلاج مجاني من حيث المبدأ.*
- **المال.** 176–549 مليون فرنك أفريقي (300,000–936,000 دولار أمريكي)؛ وإيصال علاج سوء التغذية إلى آخر نقطة هو ما ينقذ أكبر عدد من الأرواح.
- **ما لا ينبغي فعله.** لا تعتمدوا على التطعيم القديم ضد التهاب السحايا: فهو لا يحمي من سلالة المجموعة المصلية C المنتشرة الآن في شرق تشاد.*

لكم، بوصفكم من السكان	8 خطوات	p. 2
ما ينبغي فعله	**9** إجراءات	p. 5
من يفعل ماذا	مصفوفة RACI	p. 12
أين يحقق المال أكبر أثر	التمويل	p. 12
لا تفعلوا هذا	**6** بنود	p. 14
ما حدث هنا	السجل	p. 16
كيف أُعدّ هذا التقرير	المنهجية	p. 18
المراجع	المصادر	p. 20

* صياغة مقترحة: يُرجى التحقق منها مع عامل صحي قبل نشرها

بالنسبة لأسرة في منقو، يكون حر ظاهرة النينيو أشد خطرًا على الطفل النحيف أو المحموم أصلًا، ويأتي في وقت تكون فيه المياه شحيحة وغالية. ويمتد موسم التهاب السحايا من يناير إلى مايو، ويبدأ موسم الجوع التالي في يونيو. الإجراءات المرتّبة أدناه موجّهة إلى الولاية وشركائها. أما هذه فهي الخطوات التي يمكنكم اتخاذها بأنفسكم.

اعرضوا كل طفل دون الخامسة على المركز الصحي الآن لقياس محيط منتصف الذراع بالشريط (MUAC)، ثم كل شهر حتى مايو *

مؤكَّد جزئيًا · من الإجراء 1

الموعد	التكلفة عليكم	يحمي
نوفمبر 2026، ثم شهريًا	**مجاني من حيث المبدأ؛ اسألوا في وحدة التغذية**	**الأطفال الصغار**

الطفل المصاب بالهزال الشديد أكثر عرضة للوفاة بسبب الحمى أو الإسهال أو يوم حار بعدة أضعاف مقارنة بالطفل جيد التغذية. وتعالج وحدة التغذية العلاجية (UNT) في المستشفى الولائي بمنقو سوء التغذية الحاد بدعم من اليونيسف والاتحاد الأوروبي. ويقول العاملون فيها إن الحالات تتضاعف بين أبريل وأكتوبر. والعلاج المجاني هو القاعدة من حيث المبدأ، لكن تعذّر التأكد من ذلك في نص رسمي.

ابتداءً من يناير، خذوا كل من يعاني من حمى شديدة وتيبّس في الرقبة إلى المستشفى في اليوم نفسه *

مؤكَّد جزئيًا · من الإجراء 3

الموعد	التكلفة عليكم	يحمي
يناير–مايو 2027	**أجرة النقل؛ والعلاج مجاني أثناء الأوبئة**	**الأطفال والشباب**

في أدري، شرق تشاد، ارتفعت حالات التهاب السحايا من 18 حالة في يناير إلى 109 حالات في مارس 2026، وتوفي نحو طفل من كل ثمانية أطفال أُدخلوا المستشفى. وجرعة واحدة من المضاد الحيوي المناسب، تُعطى مبكرًا، تنقذ معظمهم. أما حقنة MenAfriVac التي تلقاها كثير من الناس قبل سنوات فهي لا تحمي إلا من المجموعة المصلية A، ولا تحمي من سلالة المجموعة المصلية C المنتشرة حاليًا.

قبل مارس، احتفظوا في البيت بمياه تكفي يومين إلى ثلاثة أيام في أوعية مغطاة

مؤكَّد جزئيًا · من الإجراء 4

الموعد	التكلفة عليكم	يحمي
28 فبراير 2027		**مياه الشرب في أشد الأسابيع حرًا**

* صياغة مقترحة: يُرجى التحقق منها مع عامل صحي قبل نشرها

نحو 2,000 فرنك أفريقي (3.40 دولار أمريكي) لجركن سعة 20 لترًا (سعر في الكاميرون)، إضافة إلى 2,000–3,750 فرنكًا أفريقيًا (3.40–6.40 دولار أمريكي) ثمنًا للمياه

في مارس 2026، دفعت الأسر في القطاعات 1 و2 و3 لباعة المياه على العربات 1,000–1,250 فرنكًا أفريقيًا يوميًا، لأن عدد الآبار العاملة قليل جدًا، ويرتفع الطلب مع الحر. والمخزون الذي يُشترى قبل موسم الحر يحمي الأسرة من أسوأ أيام الأسعار.

أبقوا كل أوعية المياه مغطاة، واغسلوها جيدًا قبل إعادة ملئها*

مؤكَّد جزئيًا | من الإجراء 4

الموعد	التكلفة عليكم	يحمي
الآن، وطوال موسم الجفاف	**غطاء**	**الأسرة من الكوليرا والإسهال**

وصلت الكوليرا إلى بيتكين، في قيرا، عام 2025: 220 حالة و7 وفيات حتى أواخر سبتمبر. والمياه المشتراة من العربات والمخزّنة مكشوفة هي أسهل طريق لانتقالها من بيت إلى بيت.

احتفظوا في البيت بعشرة أكياس من أملاح الإرواء الفموي لطفل مصاب بالإسهال*

مؤكَّد جزئيًا | من الإجراء 2

الموعد	التكلفة عليكم	يحمي
30 نوفمبر 2026	**لم يُعثر على سعرها في تشاد**	**الأطفال الصغار**

أملاح الإرواء الفموي هي ما يُبقي الطفل المصاب بالإسهال على قيد الحياة حتى تصل المساعدة: إذ تقدّر الدراسات المجمّعة انخفاض وفيات الأطفال بسبب الإسهال بنحو 69%. وهي متوفرة في المركز الصحي؛ واطلبوا أيضًا جرعات الزنك.*

في أشد ساعات الحر من مارس إلى مايو، استريحوا في الظل وبلّلوا الجلد؛ فالمروحة لا تفيد إلا تحت نحو 38 درجة مئوية*

مؤكَّد جزئيًا | خاص بالسكان

الموعد	التكلفة عليكم	يحمي

* صياغة مقترحة: يُرجى التحقق منها مع عامل صحي قبل نشرها

مارس–مايو 2027	لا شيء	كبار السن والعاملين وكل مريض

أشد أشهر منقو حرًا هي مارس إلى مايو، بمتوسط نحو 39 درجة مئوية عند الظهيرة، وقد توقعت مصلحة الأرصاد الجوية 45 درجة مئوية في مايو 2024. وفي الحر الجاف جدًا، قد تزيد المروحة التي تهب على جلد جاف من حرارة الجسم. وفوق نحو 38 درجة مئوية، بلّلوا الجلد أولًا، ثم دعوا الهواء المتحرك يبرّده.*

تفقّدوا كل يوم جارًا مسنًا أو مريضًا خلال موجات الحر، وأبلغوا رئيس الحي (chef de quartier) بمن يعيش وحده

مؤكَّد جزئيًا · من الإجراء 6

الموعد	التكلفة عليكم	يحمي
ابتداءً من نوفمبر	لا شيء	الأشخاص الذين لا يتفقدهم أحد

الذين يموتون في الطقس الحار هم الذين لا يراهم أحد. ولرئيس الحي مندوب في البلدية أصلًا، فالاسم الذي يُبلَّغ إليه يمكن أن يصل إلى من ينظّمون عمليات التفقد.

اشتروا الدخن أو الذرة الرفيعة لموسم الجوع بعد وصول المحصول الجديد إلى السوق، لا قبل ذلك، وخزّنوها في أكياس محكمة الإغلاق

مؤكَّد جزئيًا · من الإجراء 8

الموعد	التكلفة عليكم	يحمي
أواخر نوفمبر 2026 – يناير 2027	الأسعار متفاوتة؛ بيع كيس مدعوم وزنه 50 كيلوغرامًا بسعر 7,500 فرنك أفريقي (12.80 دولار أمريكي) في ماندول عام 2026	الغذاء في يونيو–سبتمبر 2027

في أواخر أغسطس تضاعف سعر كيس البربري في منقو ثلاث مرات خلال أسبوع، بعد موسم أمطار ضعيف، وحصاد هذا العام متأخر ويمتد إلى نوفمبر. والأسعار الآن في ذروتها الموسمية. اشتروا بعد وصول الحبوب الجديدة إلى السوق، واحفظوها في أكياس محكمة ثلاثية الطبقات إذا استطاع مكتب الزراعة توفيرها.

ما تطلبونه من المسؤولين

- اسألوا المندوبية الولائية للصحة العامة عمّا إذا كان أطفال قيرا يحصلون على الحصة الكاملة البالغة 14 كيسًا من الغذاء العلاجي في الأسبوع (الإجراء 1).

* صياغة مقترحة: يُرجى التحقق منها مع عامل صحي قبل نشرها

- اسألوا الولاية والبلدية متى سيُشغَّل خزان المياه سعة 500 متر مكعب، وأي الآبار سيتم إصلاحها قبل مارس (الإجراء 4).
- اسألوا البلدية كيف يمكن تسجيل أسر منقو في السجل الاجتماعي الوطني، حتى تصلها المساعدات النقدية في الأزمات (الإجراء 5).
- اسألوا مندوبية التجارة عمّا إذا كان المكتب الوطني للأمن الغذائي (ONASA) سينظّم بيعًا للحبوب بأسعار مدعومة في قيرا عام 2027 (الإجراء 8).

ما ينبغي أن يفعله هذا المكان

مرتّبة

مرتّبة حسب عدد الأرواح المتوقع إنقاذها مقابل كل وحدة جهد قبل الذروة. وتُعرض زوايا النظر الداعمة لكل إجراء؛ والإجراء الذي توصلت إليه عدة زوايا بشكل مستقل هو الرهان الأقوى.

1. الإبقاء على فحص سوء التغذية وعلاجه مستمرين حتى مايو: تمويل الإيصال إلى آخر نقطة والإشراف، والتأكد من حصول أطفال قيرا على الجرعة الكاملة

مؤكَّد جزئيًا | الصحة العامة · المانح · مدير الطوارئ | سجل التكيف (ADAPTATION INVENTORY): لم يُراجَع

الجهة المسؤولة	الموعد	التكلفة	يمنع
المندوبية الولائية للصحة العامة بقيرا، مع اليونيسف ووحدة التغذية العلاجية بمنقو	**من الآن حتى مايو 2027**	**176 مليون فرنك أفريقي (300,000 دولار أمريكي)**	**وفيات الأطفال المصابين بالهزال بسبب الحر والحمى والإسهال**

وجد مسح SMART لعام 2024 نسبة سوء تغذية حاد قدرها 13.3% في قيرا، منها 1.8% حاد وخيم. ويبلغ معدل وفيات الأطفال المصابين بالهزال الشديد نحو 11.6 ضعف معدل وفيات الأطفال جيدي التغذية (Olofin et al. 2013). ومعظم وفيات الحر التي يحصيها النموذج هنا ستكون لهؤلاء الأطفال الذين يموتون بالملاريا أو الجفاف في يوم حار. وتفيد اليونيسف بأن الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام (RUTF) في تشاد ممولة حتى مايو 2027، فالفجوة إذن هي نقلها من المستودع إلى المراكز الصحية في قيرا. وتفترض التكلفة 3,000 طفل بنحو 100 دولار أمريكي لكل طفل للإيصال والرعاية.

* صياغة مقترحة: يُرجى التحقق منها مع عامل صحي قبل نشرها

صُحّح في مرحلة التحقق: عدد الحالات البالغ 3,000 وتكلفة الوحدة البالغة 100 دولار أمريكي افتراضات تخطيطية بلا مصدر. وأرقام فعالية التكلفة المنشورة (42 دولارًا أمريكيًا لكل سنة حياة مصححة باحتساب العجز في ملاوي، و53 دولارًا في زامبيا) تقارن برنامجًا كاملًا بانعدام البرنامج، ولذلك فهي تبالغ في قيمة إضافة دعم الإيصال إلى آخر نقطة لبرنامج قائم أصلًا. وتقرير أطباء بلا حدود عن تقليص الحصص إلى 10 أكياس في الأسبوع يخص شرق تشاد، لا قيرا.

2. تجهيز ركن مظلل للتبريد والإرواء في المستشفى الولائي بمنقو بحلول 15 فبراير، وتزويد المراكز الصحية بأملاح الإرواء الفموي والزنك

مؤكَّد جزئيًا · مدير الطوارئ · الصحة العامة · المانح · سجل التكيف (ADAPTATION INVENTORY): لم يُراجَع

الجهة المسؤولة	الموعد	التكلفة	يمنع
المندوبية الولائية للصحة العامة بقيرا، مع المستشفى الولائي	**15 فبراير 2027، قبل حر مارس–مايو**	**نحو 3 ملايين فرنك أفريقي (5,100 دولار أمريكي)، تقديرًا**	**وفيات الرضّع وكبار السن بسبب الحر المسجّلة على أنها «حمى»**

يبلغ متوسط درجات الحرارة عند الظهيرة في أشد أشهر منقو حرًا نحو 39 درجة مئوية (مارس 39.0، أبريل 38.7، مايو 38.6 درجة مئوية، المعدلات المرجعية 1961–1990)، وقد توقعت الوكالة الوطنية للطيران المدني والأرصاد الجوية (ANAM) 45 درجة مئوية ليوم 3 مايو 2024. وليس لدى تشاد نظام رسمي للإنذار الصحي من الحر، ولذلك يجب أن يكون المستشفى جاهزًا من دونه. وفي سبتمبر 2025 وجد الوزير أن المستشفى يعاني من نقص في الموظفين وفي أطقم العمليات القيصرية.

قابلية النقل: الأدلة على خطط مواجهة الحر (أحمد آباد، Hess et al. 2018) مصدرها مدينة هندية، والأدلة على أملاح الإرواء الفموي تتعلق بالإسهال لا بالحر. صُحّح في مرحلة التحقق: يبلغ متوسط أكتوبر 34 درجة مئوية، ولذلك فإن الرقم الكبير الذي يسجّله المتتبّع لأكتوبر يعكس حرًا يفوق المعتاد لهذا الموسم، لا أشد الأسابيع حرًا.

3. قبل يناير، تزويد كل مستشفى في المقاطعات الصحية بالسيفترياكسون والاختبارات السريعة، ورصد التهاب السحايا أسبوعيًا، وإعداد طلب اللقاح الطارئ جاهزًا للإرسال

مؤكَّد جزئيًا · مدير الطوارئ · الصحة العامة · المؤرخ · سجل التكيف (ADAPTATION INVENTORY): لم يُراجَع

الجهة المسؤولة	الموعد	التكلفة	يمنع
المندوبية الولائية للصحة العامة بقيرا	**31 ديسمبر 2026؛ والرصد ابتداءً من الأسبوع الأول من 2027**	**29 مليون فرنك أفريقي (50,000 دولار أمريكي)، تُحفظ احتياطيًا**	**تأخرًا يتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع قبل تأكيد التفشي ووصول اللقاح**

* صياغة مقترحة: يُرجى التحقق منها مع عامل صحي قبل نشرها

ضرب أول تفشٍّ للمجموعة المصلية C في تشاد ولاية وداي عام 2025، واستخدمت البلاد لقاح Men5CV الجديد لأول مرة، بشكل تفاعلي، في يوليو 2025. وتُفرج مجموعة التنسيق الدولية (ICG) عن اللقاح عندما تتجاوز مقاطعة صحية عتبة الوباء (10 حالات مشتبه بها لكل 100,000 نسمة في الأسبوع، لمقاطعة يتراوح عدد سكانها بين 30,000 و100,000) وتتقدم بالطلب خلال سبعة أيام. ولم تُسجَّل أي حالة في قيرا. والمقاطعات الصحية هي منقو وبيتكين وملفي ومانقالمي.

صُحّح في مرحلة التحقق: لا يوجد طريق إمداد لحملة وقائية بلقاح Men5CV قبل يناير (لم يُبرمج التحالف العالمي للقاحات Gavi أي حملة وقائية لتشاد)، ولذلك فإن الطلب التفاعلي هو الخطة الواقعية. أما انخفاض التهاب السحايا في تشاد بنسبة 94% بفضل MenAfriVac فكان ضد المجموعة المصلية A.

4. قبل مارس، تمويل إصلاح الآبار القائمة في منقو وقطع غيارها وتوفير ميكانيكي لها، وتعقيم نقاط المياه بالكلور، ونشر موعد تشغيل خزان المياه

مؤكَّد جزئيًا | المشكّك · المؤرخ · مدير الطوارئ · المستجيب الميداني | سجل التكيف (ADAPTATION INVENTORY): لم يُراجَع

الجهة المسؤولة	الموعد	التكلفة	يمنع
ولاية قيرا، مع البلدية والمندوبية الولائية للمياه والشركة التشادية للمياه (STE)	**28 فبراير 2027**	**غير مقدّرة؛ غير ممولة**	**عجز الأسر عن شراء المياه في الحر؛ والكوليرا**

لا تزال المدينة تعتمد على منشأة الشركة التشادية للمياه القديمة سعة 100 متر مكعب. وقد وُعد في أبريل 2021 بخزان سعة 1,000 متر مكعب و20 كيلومترًا من الأنابيب؛ وبحلول يونيو 2025 أصبح المشروع 500 متر مكعب و14 كيلومترًا، وكان من المقرر إنجازه في ديسمبر 2025، ولا يوجد ما يدل على تشغيله. وفي دراسة شملت 600 موقع ريفي، كان توفر الإصلاح بتكلفة معقولة أفضل مؤشر على عمل المضخة، وكان غائبًا في 62% منها (Whaley 2019). ولا يستحق حفر آبار جديدة إلا إذا اقترن بميزانية للإصلاح. وقد دُرّبت لجان إدارة المياه في منقو في أبريل 2025، لكن لم يُذكر أي صندوق للإصلاح.

* صياغة مقترحة: يُرجى التحقق منها مع عامل صحي قبل نشرها

صُحّح في مرحلة التحقق: لم يُعثر على أي إحصاء لآبار منقو، العاملة منها أو المعطلة، والأدلة ريفية لا حضرية. والاتفاق على سقف للأسعار مع باعة المياه على العربات لم يُجرَّب هنا، ولذلك أُبقي سؤالًا لا إجراءً.

5. إدراج قيرا في الأموال التي تتحرك أصلًا عند تحقق شرط محدد: إطار الجفاف لعام 2027، ونافذة الصدمات في شبكة الأمان التابعة للبنك الدولي، والسجل الاجتماعي

مؤكَّد جزئيًا | الاقتصادي | سجل التكيف (ADAPTATION INVENTORY): لم يُراجَع

الجهة المسؤولة	الموعد	التكلفة	يمنع
وزارة العمل الاجتماعي، مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تشاد وولاية قيرا	**قبل مراجعة الإطار لعام 2027 (ربيع 2027)**	**إدارية؛ وفي حال التفعيل، نحو 8,384 فرنكًا أفريقيًا (14.28 دولارًا أمريكيًا) للفرد شهريًا**	**اضطرار الأسر إلى بيع ماشيتها في سوق منهارة من أجل البقاء**

فُعّل إطار العمل الاستباقي لمواجهة الجفاف في تشاد في 5 مايو 2026، استنادًا إلى التنبؤات الموسمية للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF). ووصلت حصة برنامج الأغذية العالمي، البالغة 4.9 مليون دولار أمريكي (1.96 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ CERF و2.94 مليون دولار من النمسا)، إلى 170,472 شخصًا في سبع ولايات، ولم تكن قيرا من بينها. ويغطي مشروع شبكات الأمان التكيفية والمنتجة التابع للبنك الدولي (100 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية IDA إضافة إلى 20 مليون دولار من صندوق استئماني) تسع ولايات، ليس من بينها قيرا. ويتضمن نافذة للصدمات لصالح 40,000 أسرة في حالات الجفاف. أما طبقة الاستجابة للصدمات في السجل الاجتماعي فلا تغطي إلا كانم وبحر الغزال.

* صياغة مقترحة: يُرجى التحقق منها مع عامل صحي قبل نشرها

صُحّح في مرحلة التحقق: كان المبلغ المخصص من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ نفسه 4.4 مليون دولار أمريكي موزعة على منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي؛ أما مبلغ 4.9 مليون دولار فهو تفعيل برنامج الأغذية العالمي بما في ذلك مساهمة النمسا، ولا يجوز جمع المبلغين. وتقدير 10,000 أسرة في قيرا بواقع 50,306 فرنكات أفريقية لكل منها (503 ملايين فرنك أفريقي، 857,000 دولار أمريكي) هو حسابنا نحن، وليس رقمًا صادرًا عن البنك الدولي.

6. التحذير عبر إذاعة منقو المجتمعية (Radio Communautaire de Mongo) ورؤساء الأحياء والأئمة والقساوسة، بالعربية التشادية واللغات المحلية، ومطالبة باعة المياه على العربات بالإبلاغ عن البيوت التي تتوقف عن شراء المياه

مؤكَّد جزئيًا | المستجيب الميداني · المشكّك | سجل التكيف (ADAPTATION INVENTORY): لم يُراجَع

الجهة المسؤولة	الموعد	التكلفة	يمنع
بلدية منقو، مع رؤساء الأحياء والقادة الدينيين	**ابتداءً من نوفمبر 2026**	**شبه معدومة**	**تحذيرات لا تصل أبدًا إلى الأسر المعزولة والفقيرة**

درّبت إذاعة منقو المجتمعية منتجين باللغات المحلية في يناير 2026. ونادي مستمعيها ينظّم أصلًا حملات تطوعية للتنظيف. والعربية التشادية هي لغة التواصل بين شعوب الحجراي في منقو، ومن لغاتهم الدنقليت والكنقا والميقاما؛ أما الفرنسية فلا تُستخدم إلا في المكاتب. ويُعدّ كل رئيس حي قائمة بكبار السن المعزولين والأشخاص ذوي الإعاقة وتلاميذ الخلاوي القرآنية لتفقّدهم يوميًا في الأيام الحارة. والأسرة التي تنفق 1,000 فرنك أفريقي يوميًا على المياه ثم تتوقف عن الشراء تكون في محنة، وبائع المياه على العربة هو أول من يعلم بذلك.

صُحّح في مرحلة التحقق: إذاعة صوت النجاة (Sôt-Al-Nadja، على الموجة 98.3 FM)، التي افتُتحت في أغسطس 2026، محطة إنجيلية، ولذلك ينبغي أن تبث الرسائل لكن دون أن تتصدرها في مدينة غالبية سكانها من المسلمين. ولم يُتأكد من وجود بث بلغة الدنقليت أو الكنقا.

7. إيصال رسائل الإحالة وأملاح الإرواء الفموي وفحص الملاريا إلى مخيمات الرحّل حول منقو وملفي وبيتكين، بإشراك متطوعي الصليب الأحمر مع أعوان الصحة المجتمعية

مؤكَّد جزئيًا | مدير الطوارئ | سجل التكيف (ADAPTATION INVENTORY): لم يُراجَع

الجهة المسؤولة	الموعد	التكلفة	يمنع
المندوبية الولائية للصحة العامة، مع لجنة الصليب الأحمر التشادي في قيرا	**نوفمبر 2026 – مارس 2027**	**نحو 5 ملايين فرنك أفريقي (8,500 دولار أمريكي)، تقديرًا؛ غير ممولة**	**الوفيات في المخيمات التي لا تصل أبدًا إلى عيادة**

* صياغة مقترحة: يُرجى التحقق منها مع عامل صحي قبل نشرها

في أكتوبر 2021، في مخيمات للرحّل قرب ملفي، مرض 52 شخصًا بما تبيّن لاحقًا أنه الملاريا، وتوفي 7–8 منهم. وكانوا قد اعتمدوا على معالجين متجولين. ولدى تشاد منذ عام 2015 سياسة للتكفل المجتمعي بالملاريا والالتهاب الرئوي، ولذلك ينبغي أن يأتي الفحص والعلاج من أعوان الصحة المجتمعية، على أن يتولى متطوعو الصليب الأحمر العثور على المرضى وإحالتهم.

صُحّح في مرحلة التحقق: لا يوجد مصدر يأذن لمتطوعي الصليب الأحمر بإجراء الفحص أو تقديم العلاج. وقد نفت الوزارة أعداد الوفيات الأعلى التي أُشيعت آنذاك (من 50 إلى 91).

8. مطالبة المكتب الوطني للأمن الغذائي (ONASA) بتنظيم بيع الحبوب بأسعار مدعومة في قيرا لموسم الفجوة الغذائية لعام 2027، وأن ينشر مكتب التجارة أسعار الحبوب في منقو كل أسبوع

مؤكَّد جزئيًا · الإمداد الغذائي · المؤرخ · سجل التكيف (ADAPTATION INVENTORY): لم يُراجَع

الجهة المسؤولة	الموعد	التكلفة	يمنع
المكتب الوطني للأمن الغذائي (ONASA)، مع المندوبية الولائية للتجارة	**الطلب بحلول مارس 2027؛ والبيع قبل يونيو**	**دعم البيع غير مقدّر**	**مواجهة موسم الجوع لعام 2027 بأسعار أغسطس 2026**

جاءت أسوأ سنوات قيرا بعد ظاهرة النينيو بموسم، لا أثناءها: فقد أعقبت مجاعة 1983–1984 ظاهرة 1982–1983، وكانت قيرا من أشد المناطق تضررًا عام 2010 بعد حصاد سيئ عام 2009. وكانت أمطار 2026 متأخرة ومتقطعة (منظمة الأغذية والزراعة، سبتمبر 2026). ونظّم المكتب الوطني للأمن الغذائي بيعًا مدعومًا في ماندول ابتداءً من 5 أغسطس 2026 بسعر 7,500 فرنك أفريقي لكيس 50 كيلوغرامًا من الذرة الرفيعة أو الذرة الشامية، لكن لم يُعثر على أي بيع في قيرا. وأعلن مندوب التجارة عن عمليات تفتيش للأسواق بعد ارتفاع الأسعار في أغسطس.

* صياغة مقترحة: يُرجى التحقق منها مع عامل صحي قبل نشرها

صُحّح في مرحلة التحقق: يعيد المكتب الوطني للأمن الغذائي تكوين مخزونه جزئيًا من الواردات، لا من شراء المحصول المحلي، ولذلك حُذفت عبارة «الشراء محليًا عند الحصاد». ونشر الأسعار أسبوعيًا لا يحدث بعد، وشبكة نظم الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) لا تغطي سوق منقو.

9. إعداد بروتوكول للعمل المبكر لمواجهة موجات الحر لدى الصليب الأحمر في قيرا لعام 2027، على غرار البروتوكول الذي تستخدمه بوركينا فاسو في واغادوغو

مؤكَّد جزئيًا | الاقتصادي | سجل التكيف (ADAPTATION INVENTORY): لم يُراجَع

الجهة المسؤولة	الموعد	التكلفة	يمنع
الصليب الأحمر التشادي، مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والوكالة الوطنية للطيران المدني والأرصاد الجوية	**تُعدّ مسودته قبل موسم الحر لعام 2027**	**مرجعيًا 219,935 فرنكًا سويسريًا (157 مليون فرنك أفريقي، 267,000 دولار أمريكي) لواغادوغو؛ غير ممولة**	**وصول موجة الحر التالية دون أي أموال مُفرج عنها مسبقًا**

بروتوكول العمل المبكر الوحيد لدى الصليب الأحمر التشادي يخص الفيضانات في ست ولايات (192,833 فرنكًا سويسريًا، اعتُمد في أغسطس 2024، ولم يُفعَّل في 2025). ويموّل بروتوكول بوركينا فاسو لموجات الحر في واغادوغو الإنذار المبكر والمياه وتفقد المصابين بأمراض مزمنة والمساعدات النقدية، استنادًا إلى توقعات لدرجات الحرارة مماثلة لتوقعات الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية. وتحتاج نسخة خاصة بقيرا إلى عتبة تُحدَّد وفق محطة منقو.

صُحّح في مرحلة التحقق: هذا الإجراء يحمي الموسم التالي أكثر من الموسم الحالي. واستُبعد التأمين السيادي ضد الجفاف عبر القدرة الأفريقية لمواجهة المخاطر (African Risk Capacity)، لأنه تعذّر التأكد من أهلية تشاد الحالية.

* صياغة مقترحة: يُرجى التحقق منها مع عامل صحي قبل نشرها

من يفعل ماذا

مصفوفة RACI

R = المنفّذ (يقوم بالعمل) · **A** = المساءَل (جهة واحدة لكل إجراء؛ تعتمده وتُسأل عنه) · **C** = المستشار (يُستشار مسبقًا) · **I** = المُبلَّغ (يُبلَّغ لاحقًا). أُعدّت المصفوفة استنادًا إلى الجهات المسؤولة المذكورة في الإجراءات التي تم التحقق منها. ولم يُتصل بأي جهة هنا، ولم توافق أي منها على دور؛ فكل سطر هو مقترح.

الإجراء	مندوبية الصحة	المستشفى الولائي ووحدة التغذية العلاجية	اليونيسف	ولاية قيرا	بلدية منقو	مندوبية المياه والشركة التشادية للمياه	رؤساء الأحياء والقادة الدينيون	الصليب الأحمر التشادي	وزارة العمل الاجتماعي وأوتشا	المكتب الوطني للأمن الغذائي ومكتب التجارة
1. علاج سوء التغذية، الإيصال إلى آخر نقطة	A	R	R	I			C			
2. ركن التبريد في المستشفى، أملاح الإرواء الفموي	A	R	C	I				C		
3. الجاهزية لالتهاب السحايا	A/R	R	C	I			I	C		
4. إصلاح الآبار، الكلور، موعد تشغيل الخزان	C			A	R	R	C			
5. إدراج قيرا في الأموال المرتّبة مسبقًا			C	R	C				A/R	
6. التحذيرات وتفقّد الأحياء	C			I	A		R	R		
7. الوصول إلى مخيمات الرحّل	A	C		I			C	R		
8. بيع الحبوب والأسعار الأسبوعية				C	I				C	A/R
9. بروتوكول الصليب الأحمر لموجات الحر	C			I				A/R	C	

ما تُظهره المصفوفة: المندوبية الولائية للصحة العامة هي الجهة المساءَلة عن أربعة من الإجراءات التسعة، وتحمل الجوهر الذي ينقذ الأرواح. أما الولاية فهي مساءَلة عن المياه وحدها، لكنها مُبلَّغة أو منفّذة في معظم الأسطر. والإجراءات 5 و6 و8 لا تكلّف شيئًا تقريبًا؛ فهي تحتاج إلى قرارات في إنجمينا وفي البلدية، لا إلى المال.

أين يحقق المال أكبر أثر

التمويل

زاوية نظر المانح، بعد مواءمتها مع الإجراءات المرتّبة والتحقق منها. والمخصصات مرتّبة حسب الأرواح الإضافية التي يُنقذها كل دولار. والمبلغ الإجمالي محدود بما يستطيع هذا المكان إنفاقه قبل الذروة، لا بما يحتاج إليه. وهو يغطي ولاية قيرا، على أن تكون وحدة التغذية العلاجية بمنقو نقطة الإحالة.

الحد الأدنى

176 مليون فرنك أفريقي (300,000 دولار أمريكي)

الهدف

238 مليون فرنك أفريقي (405,800 دولار أمريكي)

السقف

549 مليون فرنك أفريقي (935,800 دولار أمريكي)

أكبر عامل غير مؤكد

العدد الفعلي لحالات سوء التغذية الحاد الوخيم في قيرا؛ لم يُعثر على أي رقم للحالات المقبولة

الحد الأدنى = علاج سوء التغذية مع الإيصال إلى آخر نقطة، 176.1 مليون فرنك أفريقي. الهدف = الحد الأدنى + أنشطة التوعية للصليب الأحمر (14.7 مليون فرنك أفريقي) + احتياطي للأغذية العلاجية بالجرعة الكاملة (18.1 مليون فرنك أفريقي) + احتياطي لالتهاب السحايا (29.4 مليون فرنك أفريقي) = 238.3 مليون فرنك أفريقي. السقف = الهدف + مساعدات نقدية لأسر الأطفال قيد العلاج (135.0 مليون فرنك أفريقي) + مضاعفة عدد الحالات (176.1 مليون فرنك أفريقي) = 549.4

* صياغة مقترحة: يُرجى التحقق منها مع عامل صحي قبل نشرها

مليون فرنك أفريقي. لا تُفرجوا عن بنود السقف قبل توفر بيانات المندوبية الولائية عن الحالات المقبولة وتسمية جهة محددة لتنفيذ المساعدات النقدية. واستُبعد إصلاح المياه والوصول إلى المخيمات من المبلغ الإجمالي، لأنه لا توجد جهة مستفيدة مسمّاة لأي منهما. وتغيّر الهدف بنسبة −4% في مرحلة التحقق.

الجهة المستفيدة	الاستخدام	المبلغ	الآلية	الأساس	الحكم
اليونيسف في تشاد، مخصص لمندوبية الصحة ووحدة التغذية العلاجية بمنقو	الإجراء 1: النقل والإشراف والرعاية الداخلية لنحو 3,000 طفل	176.1 مليون فرنك أفريقي (300,000 دولار أمريكي)	منحة مباشرة (مخصصة)	العلاج المجتمعي على مستوى البرنامج الكامل: 42 دولارًا أمريكيًا لكل سنة حياة مصححة باحتساب العجز (ملاوي، Wilford 2012)، و53 دولارًا (زامبيا، Bachmann 2009)؛ وهي تبالغ في قيمة إضافة الإيصال إلى آخر نقطة	مؤكَّد جزئيًا
الصليب الأحمر التشادي، عبر مقره الوطني أو الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر	الإجراءان 2 و6: أملاح الإرواء الفموي والزنك، والتوعية بالحر والإحالة في منقو	14.7 مليون فرنك أفريقي (25,000 دولار أمريكي)	منحة مباشرة	لا توجد دراسة لتكلفة الوفاة الواحدة المتجنَّبة؛ تغطية زهيدة التكلفة. ولا توجد منحة مسجلة لقيرا بهذا الحجم	مؤكَّد جزئيًا
اليونيسف في تشاد	الإجراء 1: أغذية علاجية جاهزة للاستخدام لاستعادة حصة 14 كيسًا في الأسبوع، إذا تبيّن أن الحصص مقلّصة في قيرا	18.1 مليون فرنك أفريقي (30,800 دولار أمريكي)	مخزون مُعدّ مسبقًا، يُفرج عنه عند تحقق شرط محدد	84,000 كيس بنحو 0.37 دولار أمريكي للكيس؛ والتقليص موثق في شرق تشاد فقط	لم يُتحقَّق منه بالنسبة لقيرا
المندوبية الولائية للصحة العامة بقيرا	الإجراء 3: السيفترياكسون والاختبارات السريعة والرصد	29.4 مليون فرنك أفريقي (50,000 دولار أمريكي)	مخزون مُعدّ مسبقًا، يُفرج عنه عند بلوغ عتبة الإنذار	العلاج الافتراضي وفق منظمة الصحة العالمية؛ واللقاح يأتي مجانًا من مجموعة التنسيق الدولية	مؤكَّد جزئيًا
جهة منفّذة للمساعدات النقدية تُسمّى لاحقًا	مساعدات نقدية لأسر الأطفال قيد العلاج (ضمن السقف فقط)	135.0 مليون فرنك أفريقي (229,900 دولار أمريكي)	تحويل نقدي	Grellety et al. 2017 (جمهورية الكونغو الديمقراطية): التعافي 1.35 ضعف، والانتكاس 0.30 ضعف، بواقع 40 دولارًا أمريكيًا شهريًا لمدة 6 أشهر؛ وهذا التحويل أصغر وأقصر	مؤكَّد جزئيًا

* صياغة مقترحة: يُرجى التحقق منها مع عامل صحي قبل نشرها

الجهة المستفيدة	الاستخدام	المبلغ	الآلية	الأساس	الحكم
اليونيسف في تشاد، مخصص كما سبق	الإجراء 1 بضعف عدد الحالات (ضمن السقف فقط)	176.1 مليون فرنك أفريقي (300,000 دولار أمريكي)	منحة مباشرة (مخصصة)	لا يُفرج عنه إلا إذا أظهرت بيانات الحالات المقبولة أكثر من 3,000 طفل	مؤكَّد جزئيًا

من منظور المانح: لا تشتروا الأغذية العلاجية. فاليونيسف تفيد بأن الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام في تشاد ممولة حتى مايو 2027. وما لم يُموَّل هو نقلها من المستودع إلى المراكز الصحية في قيرا. وأرخص الأموال على الإطلاق لا يكلّف شيئًا: إدراج قيرا في إطار الجفاف وفي نافذة الصدمات لشبكة الأمان (الإجراء 5).

لا تفعلوا هذا

محظور · نصائح قد تكلّف أرواحًا هنا

نصائح متداولة بشأن هذا الخطر وقد تكلّف أرواحًا هنا.

الاعتماد على التطعيم السابق بلقاح MenAfriVac، أو انتظار حملة وقائية، للحماية من التهاب السحايا في هذا الموسم*

محظور

اكتُشف في مرحلة التحقق. لقاح MenAfriVac لا يحمي إلا من المجموعة المصلية A. وكانت حالات التفشي في شرق تشاد في 2025 و2026 من المجموعة المصلية C، وتوفي نحو طفل من كل ثمانية أطفال أُدخلوا المستشفى في أدري. ولا توجد أي حملة وقائية بلقاح Men5CV مبرمجة لتشاد.

* صياغة مقترحة: يُرجى التحقق منها مع عامل صحي قبل نشرها

بدلًا من ذلك: تعاملوا مع الحمى المصحوبة بتيبّس الرقبة على أنها حالة طارئة، وخزّنوا السيفترياكسون، وأرسلوا الطلب إلى مجموعة التنسيق الدولية فور تجاوز أي مقاطعة صحية للعتبة (الإجراء 3).

مراكز تبريد تحتاج إلى كهرباء الشبكة أو المراوح، أو تجمع الناس في مكان مزدحم في فبراير–مايو *

محظور

تأتي كهرباء منقو من محطة هجينة تعمل بالطاقة الشمسية وُصف إنتاجها بأنه «ضعيف جدًا» في يونيو 2025. وفي الحر الجاف جدًا، ترفع المراوح التي تهب على الجلد الجاف حرارة الجسم: ففي تجربة أُجريت عام 2019 كانت ضارة عند 47 درجة مئوية ورطوبة 10%، وتضع النمذجة اللاحقة الحد الفاصل قرب 38–39 درجة مئوية. كما أن جمع الناس في فبراير–مايو يقرّب بينهم في موسم التهاب السحايا.

بدلًا من ذلك: أماكن مظللة وجيدة التهوية لا تحتاج إلى كهرباء، وتبليل الجلد مع هواء متحرك، وإيصال الرعاية إلى الناس في بيوتهم (الإجراءان 2 و6).

أن يُطلب من الناس «شرب المزيد من الماء» حيث تُشترى المياه يومًا بيوم

محظور

تدفع الأسر في القطاعات 1 و2 و3 بالفعل 1,000–1,250 فرنكًا أفريقيًا يوميًا لباعة المياه على العربات، وتقلّص استهلاكها من المياه والنظافة حين يرتفع الثمن. والنصيحة التي تتجاهل السعر لا تغيّر شيئًا لمن هم أكثر عرضة للخطر.

بدلًا من ذلك: إصلاح الآبار المعطلة (الإجراء 4)، والبحث عن دعم لتكلفة المياه في أسابيع الذروة.

حفر آبار جديدة دون ميزانية للإصلاح أو قطع غيار أو ميكانيكي

محظور

أكثر من ربع المضخات اليدوية في أفريقيا معطل في أي وقت، وتوفر الإصلاح بتكلفة معقولة هو أفضل مؤشر على عمل المضخة (Whaley 2019). والسكان يطالبون بآبار جديدة، وهم بحاجة إليها، لكن البئر التي لا يرافقها صندوق للإصلاح تصبح البئر المعطلة التالية.

* صياغة مقترحة: يُرجى التحقق منها مع عامل صحي قبل نشرها

بدلًا من ذلك: لا آبار جديدة إلا بخطة إصلاح ممولة، وإصلاح الآبار القائمة أولًا.

تخزين المياه مكشوفة

محظور

وصلت الكوليرا إلى بيتكين، في قيرا، عام 2025 (220 حالة و7 وفيات حتى أواخر سبتمبر). والمياه المشتراة من العربات والمحفوظة مكشوفة يسهل تلوثها.

بدلًا من ذلك: أوعية مغطاة ضيقة العنق، تُغسل جيدًا قبل كل إعادة ملء.*

التحذير بالفرنسية وحدها، أو عبر الرسائل النصية القصيرة وحدها

محظور

الفرنسية هي لغة المكاتب في منقو. ومعظم الناس يتحدثون العربية التشادية ولغة من لغات الحجراي، ونظام الإنذار المبكر في تشاد قليل الحلقات خارج المدن.

بدلًا من ذلك: الإذاعة المجتمعية، ورؤساء الأحياء، والأئمة، والقساوسة، بالعربية التشادية واللغات المحلية (الإجراء 6).

ما حدث هنا من قبل

السجل

السنة	الحدث	الحصيلة	ما الذي تغيّر بعده
1983–1984	مجاعة في قيرا، في العام التالي لظاهرة النينيو 1982–1983، بعد عقدين من الحرب أفرغا مخازن الحبوب	لم يُعثر على رقم خاص بقيرا؛ ووجّه الصليب الأحمر نداءً لصالح 140,000 من ضحايا الجفاف في أنحاء تشاد عام 1984	غير مسجّل
2009–2010 (النينيو)	جفاف وعجز وطني في الحبوب بنسبة 34%؛ وكانت قيرا من أشد المناطق تضررًا	سوء التغذية الحاد 16.1%، والحاد الوخيم 4.9% في قيرا	جاء الإنذار متأخرًا، مع عدد قليل جدًا من الشركاء القادرين على التنفيذ
أغسطس 2011	كوليرا بعد أمطار غزيرة	152 حالة في مستشفى منقو خلال تسعة أيام (الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر)	غير مسجّل

* صياغة مقترحة: يُرجى التحقق منها مع عامل صحي قبل نشرها

السنة	الحدث	الحصيلة	ما الذي تغيّر بعده
2012	أزمة الغذاء في الساحل؛ وكان شمال قيرا الأشد تضررًا؛ ونبشت النساء في تاسينو الحبوب من بيوت النمل	لم يُعثر على عدد للوفيات في قيرا	تأخرت المساعدات بسبب الاعتراف المتأخر بالأزمة
2026–2021	خزان مياه منقو: وُعد بسعة 1,000 متر مكعب في أبريل 2021، ثم خُفّضت إلى 500 متر مكعب، وموعد الإنجاز ديسمبر 2025	أسر تدفع 1,000–1,250 فرنكًا أفريقيًا يوميًا ثمنًا للمياه في مارس 2026	لم يُشغَّل بعد، حسب ما تُظهره المصادر
أكتوبر 2021	ملاريا في مخيمات الرحّل قرب ملفي، أُبلغ عنها في البداية على أنها مرض مجهول	52 مريضًا، و7–8 وفيات	حذّر الوزير من المعالجين المتجولين
2025	كوليرا في مقاطعة بيتكين الصحية	220 حالة و7 وفيات حتى أواخر سبتمبر	أيام للوقاية في منقو
أغسطس 2026 (النينيو)	أمطار متأخرة ومتقطعة؛ وتضاعف سعر البربري ثلاث مرات في منقو خلال أسبوع	لا ينطبق	الإعلان عن عمليات تفتيش للأسواق

التكرار الذي لم يلحظه أحد: جاءت أشد سنوات قيرا فتكًا في الموسم التالي لظاهرة النينيو، لا أثناءها. فقد أعقبت مجاعة 1983–1984 ظاهرة 1982–1983، وأعقب سوء التغذية في 2010 حصاد عام 2009. ويغطي هذا التقرير الضربة الأولى، أي الحر على الأطفال المرضى، لكن الضربة الثانية، أي موسم الفجوة الغذائية في يونيو–أغسطس 2027، ستقع على أسر استنزف موسم الحر احتياطياتها. ولم تُسجَّل في قيرا قط أي وفاة بسبب الحر أو أي تفشٍّ لالتهاب السحايا، وهذا يعكس غياب الرصد، لا الأمان.

حيث يختلف الخبراء

دون حسم

- **الخطر في أكتوبر** (المتتبّع: 330 من أصل 980 وفاة) مقابل **الخطر في مارس–مايو** (المشكّك والسجل المناخي: أشد أشهر منقو حرًا). ويمكن أن يكون كلاهما صحيحًا. فالمتتبّع يحصي الحر الذي يفوق المعتاد، والانحراف في أكتوبر يتزامن مع ذروة سوء التغذية والملاريا. وسجلات الوفيات في منقو كفيلة بحسم المسألة، لكن المدينة لا تملك نظامًا فعالًا لتسجيل الوفيات.
- **تنفيذ برنامج لمواجهة الحر** (مدير الطوارئ) مقابل **رعاية سوء التغذية والملاريا هي برنامج مواجهة الحر** (الصحة العامة). ويتبع الترتيب رأي الصحة العامة، مع ركن تبريد في المستشفى بوصفه الخطوة الوحيدة الخاصة بالحر.
- **إعطاء الأزيثروميسين مرتين في السنة لجميع الأطفال دون الخامسة** (الصحة العامة: انخفاض الوفيات من جميع الأسباب بنسبة 14% في النيجر، تجربة AVENIR، 2024) مقابل **ليس سياسة وطنية، ولا يمكن تنفيذه قبل الذروة**. استُبعد من الإجراءات المرتّبة؛ ويستحق طرحه على الوزارة لعام 2027.

* صياغة مقترحة: يُرجى التحقق منها مع عامل صحي قبل نشرها

- **شراء الحبوب محليًا عند الحصاد لتثبيت الأسعار** (الإمداد الغذائي) مقابل **المكتب الوطني للأمن الغذائي يشتري من الواردات حتى لا يُحدث نقصًا محليًا** (التحقق). أُبقي طلبًا للبيع في قيرا، لا للشراء المحلي.

ما لم يغطّه أحد — نقطة عمياء

لم تتناول أي زاوية نظر النساء الحوامل والولادات في الحر، رغم أن مستشفى منقو كان يعاني من نقص في أطقم العمليات القيصرية وفي الموظفين في سبتمبر 2025. ولم تُحصِ أي زاوية النازحين في منقو أو الرعاة العابرين في موسم الجفاف، ولم تعثر أي منها على مرحلة الإطار المنسق (Cadre Harmonisé) الخاصة بقيرا لهذا الموسم. وأحدث مسح لسوء التغذية يعود إلى عام 2024.

كيف تقرؤون هذا — المنهج

اللجنة من إعداد المؤلف. استُخدمت ثماني زوايا نظر خبيرة محاكاة لتوليد هذه التوصيات. وحيث تتفق، فذلك فرضية قوية، لا إجماع في هذا المجال. ثم جرى التحقق من كل توصية بشكل مستقل من حيث الأدلة، وقابلية نقلها إلى هذا المكان، وإمكانية تنفيذها قبل الذروة؛ وتحمل وسوم الحكم النتيجة.

أرقام الوفيات منشورة على مستوى الولاية، لقيرا. وهي ليست أرقامًا لمنقو نفسها. ويغطي إسقاط ظاهرة النينيو *الحر وحده*؛ أما الجفاف والفيضانات والحرائق والدخان وفشل المحاصيل فهي إضافية إليه، ويغطيها هنا السجل التاريخي لا رقم منشور.

كيف أُعدّ هذا التقرير — المنهجية

- **النطاق.** أُخذ الموقع كما حُدّد: منقو، عاصمة ولاية قيرا، تشاد. ولا توجد أرقام للوفيات إلا على مستوى الولاية؛ وتُستخدم تفاصيل المدينة لتقدير التعرض للخطر وتصميم الإجراءات، لا لإحصاء الوفيات. وتعذّر التأكد من عدد سكان المدينة الحالي، ولذلك لا تُقدَّم حصة لمنقو من رقم الولاية.
- **التعرّض.** بيانات متتبّع وفيات الحر المرتبطة بظاهرة النينيو الصادر عن مختبر الأثر المناخي (Climate Impact Lab)، الملف `v261026_adm1_output_BASE_rounded_cust.csv` (نسخة 26 أكتوبر 2026، قبل مراجعة الأقران): قيرا (GADM TCD.7_1)، 350 وفاة إضافية بسبب الحر في يونيو–سبتمبر 2026، و980 وفاة متوقعة في أكتوبر 2026 – مارس 2027 (أكتوبر 330، نوفمبر 230، ديسمبر 70، يناير 68، فبراير 62، مارس 210)، أي 1,300 في المجموع؛ وتشاد 17,000؛ والعالم 857,400. ويحل هذا التحديث محل تقرير سبتمبر *451,000 at Risk*. المنهج: تطبيق التنبؤات الموسمية SEAS5 الصادرة عن المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى على العلاقات بين درجات الحرارة والوفيات مقارنة بخط أساس 1996–2025. وتحصي الأرقام الحر وحده؛ وقد استنتجنا ذلك من البيانات، لأن البلدان الباردة تُظهر صفرًا تامًا في كل أشهر الشتاء. ولا تُضاف أبدًا إلى الإسقاطات طويلة الأمد في خريطة الأثر (Impact Map).

* صياغة مقترحة: يُرجى التحقق منها مع عامل صحي قبل نشرها

- **لجنة الخبراء.** بحثت ثماني زوايا نظر خبيرة محاكاة (مدير الطوارئ، وعالم الصحة العامة، والمستجيب الميداني، والمشكّك، والاقتصادي، والمؤرخ، والمانح، ومحلل سلسلة الإمداد الغذائي) كل منها في هذا المكان بشكل مستقل وبالتوازي، من مصادر على الإنترنت بالفرنسية والإنجليزية، وفق تكليف ثابت.
- **المواءمة.** دُمجت الإجراءات المكررة وسُجّلت زوايا النظر الداعمة. واختُبر التقارب بحثًا عن تحيز مشترك (أي ما إذا كانت الأدلة وراء إجراء متفق عليه مستمدة من سياق مشابه لهذا السياق) قبل أن يُحتسب لصالح الإجراء. وأُبقي على التناقضات، ولم تُحسم بإسقاط أحد الطرفين. ورُتّبت الإجراءات حسب عدد الأرواح المتوقع إنقاذها مقابل كل وحدة جهد قبل الذروة، وحُدّدت لكل منها جهة دافعة مسمّاة وشرط للتفعيل أو وُصفت بأنها غير ممولة، وجرت مواءمة مخصصات التمويل مع القائمة المرتّبة.
- **التحقق.** تحقق ستة وكلاء تحقق من كل توصية وفق ثلاثة اختبارات: الأدلة (المصدر الأولي وحجم الأثر)، وقابلية النقل (ما إذا كانت تلك الأدلة مستمدة من مكان مشابه لهذا المكان)، وإمكانية التنفيذ (ما إذا كان يمكن تنفيذها هنا قبل الذروة). كما فُحصت الإجراءات المالية من حيث توفرها في هذه الولاية القضائية، ووجود جهة دافعة مسمّاة، وعتبة للتفعيل، وما إذا كانت قائمة أصلًا؛ وفُحصت الإجراءات الغذائية من حيث شروط التفعيل المنشورة والتوقيت. وفُحص المبلغ الإجمالي للتمويل من حيث وجود جهات مستفيدة حقيقية، وتكاليف وحدة منشورة، والازدواجية، ثم أُعيد جمعه.
- **من يفعل ماذا.** أُعدّت مصفوفة RACI استنادًا إلى الجهات المسؤولة المذكورة في الإجراءات التي تم التحقق منها، مع جهة مساءلة واحدة لكل إجراء. وهي مقترح: لم يُتصل بأي جهة مذكورة فيها، ولم توافق أي منها على دور.
- **الأحكام.** *مؤكَّد*: تصمد الأدلة وقابلية النقل وإمكانية التنفيذ كلها. *مؤكَّد جزئيًا*: يصمد بعد التصحيحات المبيّنة. *لم يُتحقَّق منه*: تعذّر التحقق منه بالرجوع إلى مصدر أولي. *محظور*: قد يُلحق ضررًا أو يُضيّع الفرصة الزمنية هنا.
- **سجل التكيف (Adaptation Inventory).** لم يُراجَع في هذه الدورة. فصفحة التصفح تحمّل بياناتها داخل المتصفح، وفي دورات سابقة كان رابط «Download Inventory» يؤدي إلى استمارة تسجيل. ولا ينبغي فهم أي إجراء هنا على أنه بلا سابقة؛ فلم يُفحص أي منها.
- **المال.** تُعرض التكاليف بالفرنك الأفريقي لوسط أفريقيا (XAF)، مع الدولار الأمريكي بين قوسين، بسعر 587.14 فرنكًا أفريقيًا = 1 دولار أمريكي. والسعر مستمد من الربط الثابت البالغ 655.957 فرنكًا أفريقيًا = 1 يورو ومن السعر المرجعي للبنك المركزي الأوروبي البالغ 1 يورو = 1.1172 دولار أمريكي (30 أكتوبر 2026). والأرقام المنشورة بالفرنك السويسري (بروتوكولات الصليب الأحمر) تُعرض كما نُشرت.
- **القارئ.** لم يُحدَّد أي دور، ولذلك كُتب قسم «لكم» لأحد السكان. وأُخذت خطواته من الإجراءات التي تم التحقق منها ومما وجدته اللجنة عن الأسر هنا. وكل خطوة غير مستمدة من إجراء مرتّب جرى التحقق منها وفق الاختبارات الثلاثة نفسها. أما بقية التقرير فموجّهة إلى الولاية وشركائها.
- **اللغة.** ترافق هذا التقرير نسخة بالفرنسية، لأن الفرنسية هي لغة الإدارة في تشاد. وأُضيفت في 31 أكتوبر 2026 هذه النسخة بالعربية الفصحى، وهي اللغة الرسمية الأخرى في تشاد. ومعظم سكان منقو يتحدثون العربية التشادية ولغة من لغات الحجراي؛ ولم تُعدّ نسخة بهما، ويطلب الإجراء 6 بدلًا من ذلك بث الرسائل الرئيسية بهما عبر الإذاعة. المقاطع الموسومة بعبارة «suggested formulation» هي تعليمات سلامة مترجمة لم يراجعها بعد عامل صحي ناطق بالعربية.
- **الصياغة الصحية.** المقاطع التي قد يؤدي خطأ في صياغتها إلى إيذاء أحد (التبريد والمراوح، والأدوية وجرعاتها، ومعالجة المياه وأملاح الإرواء، وعلامات الخطر، وإمدادات الطوارئ، ومتى يجب طلب المساعدة) موسومة بعبارة «* صياغة مقترحة: يُرجى التحقق منها مع عامل صحي قبل نشرها». جرى التحقق منها بالرجوع

* صياغة مقترحة: يُرجى التحقق منها مع عامل صحي قبل نشرها

إلى مصادر منشورة، لا من قِبَل مختص صحي. وهي اقتراحات وليست نصيحة طبية، وعلى كل من ينقلها أن يتأكد منها أولًا لدى طبيب أو صيدلي أو ممرض أو عامل صحة مجتمعي. أُضيفت هذه العلامة في 2 نوفمبر 2026.

- **القواعد.** لا تُشتق أي تكلفة بقسمة مجموع منشور، ولا يُختلق أي رقم محلي؛ وحيث تكون البيانات شحيحة، يذكر التقرير ذلك ويعرض رقم النطاق الجغرافي الأوسع مع طريقة حسابه. وكل مصدر مُدرج أدناه مع حالة التحقق منه.
- **الحدود.** اللجنة ووكلاء التحقق وكلاء بحث يعملون بالذكاء الاصطناعي ويعتمدون على مصادر متاحة على الإنترنت، وليسوا خبراء بشريين، ولم تُجرَ مقابلة مع أي شخص في هذا المكان. وكان هذا ثاني تقرير كامل في جلسة واحدة، ولذلك اقتصر كل وكيل تحقق على نحو 15 عملية بحث. ورفضت عدة مصادر القراءة المباشرة (الفصل الخاص بالتغذية في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، ومجموعة بيانات الأسعار لبرنامج الأغذية العالمي، وصفحة لمنظمة الصحة العالمية عن التهاب السحايا). ولم يُعثر على أي إحصاء لآبار منقو، ولا على عدد حالات سوء التغذية الحاد الوخيم في قيرا، ولا على مرحلة الإطار المنسق لقيرا، ولا على سعر للكلور أو لأملاح الإرواء الفموي في تشاد. وسعر الجركن مأخوذ من الكاميرون. وتُظهر خريطة الموقع منقو على مستوى البلد.

المراجع · الحالة بعد التحقق

مختبر الأثر المناخي (Climate Impact Lab)، بيانات متتبّع وفيات الحر المرتبطة بظاهرة النينيو v261026 (نُزّلت في 30 أكتوبر 2026)؛ المتتبّع · مؤكَّد

التغذية والصحة: مسح SMART 2024 في تشاد؛ اليونيسف، وحدة التغذية العلاجية بمنقو؛ اليونيسف، تمويل الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام، الربع الثاني 2026؛ أطباء بلا حدود، تقليص الحصص في شرق تشاد؛ اليونيسف، نداء العمل الإنساني للأطفال، تشاد 2026؛ Bachmann 2009؛ Wilford 2012؛ Grellety 2017؛ Munos 2010؛ Hess 2018؛ تجربة AVENIR؛ زيارة الوزير للمستشفى، سبتمبر 2025 · مؤكَّد جزئيًا

الحر والكهرباء: المعدلات المناخية لمنقو (WMO/DGMN)؛ توقعات الوكالة الوطنية للطيران المدني والأرصاد الجوية، مايو 2024؛ Morris 2019، المراوح؛ محطة منقو الهجينة بالطاقة الشمسية · مؤكَّد جزئيًا

التهاب السحايا والتوعية: حملة لقاح Men5CV، أبشي 2025؛ أطباء بلا حدود، أدري 2026؛ مخزونات مجموعة التنسيق الدولية؛ أثر لقاح MenAfriVac؛ عتبات التهاب السحايا؛ MenAfriCar؛ الصليب الأحمر في منقو، مايو 2026؛ ملفي 2021؛ التكفل المجتمعي بالحالات؛ إذاعة منقو المجتمعية؛ إذاعة صوت النجاة؛ رؤساء الأحياء · مؤكَّد جزئيًا

المياه: مياه الباعة، مارس 2026؛ وضع حجر الأساس للخزان، 2021؛ زيارة الخزان، يونيو 2025؛ لجان إدارة المياه؛ Whaley 2019؛ تقرير الحالة عن الكوليرا، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، سبتمبر 2025؛ الكوليرا 2011؛ سعر الجركن (الكاميرون) · مؤكَّد جزئيًا

المال: برنامج الأغذية العالمي، العمل الاستباقي، تشاد 2026؛ Anticipation Hub؛ البنك الدولي، شبكات الأمان؛ طبقة الاستجابة للصدمات في السجل الاجتماعي؛ بروتوكول العمل المبكر المبسّط للفيضانات في تشاد؛ بروتوكول العمل المبكر المبسّط لموجات الحر في بوركينا فاسو؛ خطة الاستجابة الإنسانية لتشاد 2026؛ السعر المرجعي للبنك المركزي الأوروبي · مؤكَّد جزئيًا (القدرة الأفريقية لمواجهة المخاطر: لم يُتحقَّق منها، واستُبعدت)

الغذاء والتاريخ: سعر الحبوب في منقو، أغسطس 2026؛ النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر التابع للفاو (GIEWS)، تشاد؛ FEWS NET، FEWS NET، تشاد؛ النينيو 2026–2027؛ بيع المكتب الوطني للأمن الغذائي، ماندول؛ إعادة تكوين مخزون المكتب الوطني للأمن الغذائي، 2020؛ مركز الدراسات الأفريقية في لايدن، قيرا؛ نداء 1984؛ سوء التغذية في قيرا 2010؛ إنذار FEWS NET، ديسمبر 2009؛ أزمة 2012 · مؤكَّد جزئيًا

بيانات التعرّض · مختبر الأثر المناخي (Climate Impact Lab)، 451,000 at Risk · خريطة الأثر (Impact Map) · سجل التكيف (Adaptation Inventory)

أُعدّ في 30 أكتوبر 2026 لمنقو، قيرا. مبادرة El Niño Ready يديرها متطوعون، وهي غير تابعة لأسبوع المناخ في نيويورك (Climate Week NYC) ولا لمجموعة المناخ (The Climate Group) ولا لجامعة كولومبيا.

* صياغة مقترحة: يُرجى التحقق منها مع عامل صحي قبل نشرها